

약제 요양 급여의 적절성 평가 결과

ulipristal acetate 5mg

(이니시아정, 신풍제약)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 흰색 내지 회백색의 한쪽면이 “ES5”가 새겨진 양면이 볼록한 원형 정제

☐ **효능 효과 :**

- 가임기 성인 여성에서 중등도-중증 증상을 가진 자궁근종 환자의 수술 전 치료

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의일**

2013년 제6차 약제급여평가위원회 : 2013년 6월 20일

- 중앙심사평가조정위원회 : 2013년 2월 4일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종결과

- 제약사가 [REDACTED] 원 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2013년 제6차 약제급여평가위원회평가결과: 비급여

- 신청품은 “가임기 성인 여성에서 중등도-중증 증상을 가진 자궁근종 환자의 수술 전 치료”에 허가받은 약제로 대체약제 대비 임상적 유용성 개선이 인정되나, 경제성 평가 결과 비용효과성이 불분명하므로 비급여 함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중 평균가로 환산된 금액([REDACTED] 원/팩(28정)) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음

□ 세부사항

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “가임기 성인 여성에서 중등도-중증 증상을 가진 자궁근종 환자의 수술 전 치료”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 leuprolide acetate, goserelin, triptorelin이 등재되어 있으므로, 대체가능성 등을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 선택적 프로게스테론수용체 조절제¹⁾로 “가임기 성인 여성에서 중등도-중증 증상을 가진 자궁근종 환자의 수술 전 치료”에 허가받은 약제로 myometrial 과 endometrial tissue의 프로게스테론 수용체에 작용하여 estradiol level 혹은 antiglucocorticoid activity에 큰 영향을 주지 않고 배란을 억제함으로써 자궁근종으로 인하여 발생하는 과다출혈을 조절하고 근종의 크기를 줄이는 효과를 나타냄.²⁾
- 교과서 및 가이드라인에서 자궁근종의 비수술적 치료법으로는 대표적으로 사용되는 GnRH agonist가 가성폐경 저에스트로젠 상태를 유도하여 수술 전 치료법으로 다른 치료법 (GnRH antagonist, antiprogesterin)보다 우선적으로 고려됨. 다만, GnRH agonist 제제는 안면홍조, 불면증, 두통, 근육통 등의 부작용을 유발하고 6개월 이상 투여시 골밀도 감소의 심각한 부작용 발생으로 단기투여 하도록 함.³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾
- RCT, parallel-group, 이중맹검, 3상 임상연구(PEARL-I)⁸⁾에서 약물치료 후 수술이 가능한

자궁근종 환자(18~50세 여성)를 대상으로 신청품 1일 5mg(95명), 10mg(94명) 혹은 위약(48명)을 투여한 결과, 1차 효과평가 지표인 자궁출혈조절(13주째에 PBAC 점수⁹⁾가 75미만) 환자 비율은 신청품군이 높았으며(신청품 5mg군 91%, 10mg군 92%, 위약군 19%, 신청품 각군과 위약군 비교시 $P<0.001$), 이상반응 발현에 있어서는 군간의 차이를 보이지 않았음.

- RCT, parallel-group, 이중맹검, double-dummy, 활성약 대조 3상 임상연구(PEARL-II)¹⁰⁾에서 자궁근종으로 인하여 과도한 자궁출혈이 있는 환자(18~50세 여성)에 신청품 1일 5mg(97명), 10mg(103명) 혹은 Leuprolide 3.75mg(101명)을 투여한 결과,
 - 1차 효과평가지표인 자궁출혈조절(13주째에 PBAC 점수¹¹⁾가 75미만) 환자 비율은 ulipristal acetate군에서 비열등한 결과를 나타냄(신청품 5mg 투여군이 90%, 10mg 투여군이 98%, Leuprolide 3.75m군 89%).
 - 다만, 2차 평가지표인 자궁출혈 조절 속도에 있어서는 신청품군이 대조군에 비하여 통계적으로 유의한 차이를 보이면서 빠르게 출혈 조절된 결과를 보였음($P<0.001$).
 - 안전성 및 이상반응 평가 결과, 13주째 median estradiol value(1차 평가지표)는 신청품군 5mg은 64.0pg/mL, 10mg은 60.5pg/mL, 대조군은 25pg/mL의 결과를 나타냄($P<0.001$). 또한, 중등도 이상의 안면홍조 발생(1차 평가지표)에 있어서 신청품군(5mg:11%, 10mg:10%)이 대조군(40%)에 비하여 유의하게 낮은 발생율을 보였음($P<0.001$).
 - 이 외, 2차 평가지표로 분석된 이상반응(두통, 압통, 빈혈, 비인후염, 불면증, 유방멍울로 인한 통증 등)에 대하여는 두 군 간 유의한 차이를 보이지 않았음.
 - Uterine Fibroid Symptom and Quality of Life (UFS-QoL)를 이용하여 건강관련 삶의 질 평가 결과, 신청품군과 대조군의 유의한 차이가 없었음.
- 관련 학회에서는 GnRH agonist는 폐경증상 부작용이 흔히 나타남에 따라 제한적으로 사용해야 하는 바, 동등한 출혈조절효과를 나타내고, 출혈량을 신속히 줄이면서 폐경증상 부작용을 감소시키는 효과를 나타내는 신청품이 이를 대체할 수 있으며, 특히, 신청품의 경우 3개월 간 투여시 GnRH 제제에 비하여 안면홍조에 대한 뚜렷한 개선이 있으면서 출혈량을 효과적으로 줄일 수 있다는 의견을 제시함.¹²⁾¹³⁾

○ 비용 효과성

- 신청품은 “가임기 성인 여성에서 중등도-중증 증상을 가진 자궁근종 환자의 수술 전 치료”에 허가받은 약제로 교과서¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾ 및 가이드라인¹⁹⁾에서 동일한 적응증에 권고되고 있으며, 현재 급여인정되고 있는 “leuprolide acetate, goserelin, triptorelin”을 대체약제로 선정함.
- 신청품의 치료기간 당 투약비용은 ■■■■■원/팩(28정)으로 대체약제의 가중 평균가인 ■■■■■원보다 고가임.²⁰⁾
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 ■■■■■원/팩(28정)임.
- Leuprolide 대비 신청품의 비용-효용 분석 결과, ICER는 ■■■■■원/QALY이며,

[REDACTED]

○ 재정 영향²¹⁾

1) 신청약가 기준

- 해당 적응증의 대상 환자수²²⁾는 약 [REDACTED]명이고, 제약사 제출 예상사용량²³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁴⁾은 1차 년도에 약 [REDACTED]원, 3차 년도에 약 [REDACTED]원이 되고 leuprolide acetate, goserelin, triptorelin의 대체로 재정소요금액은 1차 년도에 약 [REDACTED]원, 3차 년도에 약 [REDACTED]원 증가될 것으로 예상됨²⁵⁾.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상사용량²⁶⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은²⁷⁾ 1차 년도에 약 [REDACTED]원, 3차년도에 약 [REDACTED]원이 되고 신청품의 도입후 leuprolide acetate, goserelin, triptorelin의 대체로 인한 재정소요금액은 없을 것으로 예상됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 독일, 영국에 등재되어 있음.

Reference

- 1) Martindale, The complete Drug Reference, 37th edi.)
- 2) Ferri:Ferri's Clinical Advisor 2013, 1st ed.
- 3) 부인과학 제 4판, 2007
- 4) Berek & Novak's Gynecology, 14th edition
- 5) Textbook of Gynecology, 2012
- 6) Uterine Fibroid Tumors: Diagnosis and Treatment : Am Fam Physician 2007;75:1503-8, American Academy of Family Physicians).
- 7) Heavy menstrual bleeding - clinical guideline(2007.01, NICE)
- 8) Uliprisal Acetate versus placebo for fibroid treatment before surgery - N Engl J Med 2012;366:409-20
- 9) PBAC : the pictorial blood-loss assessment chart, in which monthly scores range from 0 to >500, with higher numbers indicating more blood
- 10) Uliprisal Acetate versus Leuprolide Acetate for Uterine Fibroids - N Engl J Med 2012;366:421-32
- 11) PBAC : the pictorial blood-loss assessment chart, in which monthly scores range from 0 to > 500, with higher numbers indicating more blood

- 12) 대한산부인과학회
- 13) 대한생식의학회
- 14) 부인과학 제 4판, 2007
- 15) Berek & Novak's Gynecology, 14th edition
- 16) Textbook of Gynecology, 2012
- 17) Uterine Fibroid Tumors: Diagnosis and Treatment : Am Fam Physician 2007;75:1503-8, American Academy of Family Physicians).
- 18) Heavy menstrual bleeding - clinical guideline(2007.01, NICE)
- 19) Uterine Fibroid Tumors: Diagnosis and Treatment : Am Fam Physician 2007;75:1503-8, American Academy of Family Physicians).
- 20) 질환의 특성과 신청품 및 대체약제의 용법·용량을 고려하여 1개월은 28일로 가정하였으며, 신청품의 포장 단위가 '28정/팩'임을 고려하여 28일의 투약 비용을 비교함.
- 21) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 22) 2012년 EDI 청구 환자수 : ,
- 23) 제약사 제시 예상 사용량(1차년도 팩, 2차년도 팩, 3차년도 팩)
- 24) 절대재정소요금액 = 제약사제출 예상사용량 x 신청약가
- 25) 재정증분 = 신청품의 예상 사용량 * (신청품의 소요비용-대체약제의 가중평균 소요비용)
- 26) 제약사 제시 예상 사용량(1차년도 팩, 2차년도 팩, 3차년도 팩)
- 27) 절대재정소요금액 = 제약사제출 예상사용량 x 대체약제 가중평균가